

21 - Les personnalités pathologiques - Pr. MANOUDI

L'étiquette adulte, c'est les personnalités pathologiques. Alors les personnalités pathologiques, c'est quelque chose qu'on sort souvent quand on est devant quelqu'un, qu'on voit par exemple des traits de personnalité, qu'on voit par exemple un comportement qui n'est pas « normal » pour nous, on lui donne déjà une étiquette. Autour de vous, je pense que vous avez donné des étiquettes à plusieurs personnes, rien qu'en les voyant, par rapport des fois juste à un trait.

Donnez-moi les étiquettes que vous vous redonnez autour de vous, dans votre entourage, entre vous. Narcissique, pervers narcissique, ça c'est l'actualité, ça c'est le top. Une femme qui a un problème avec son mari, il est pervers narcissique.

Toutes ses copines lui disent, c'est un pervers narcissique, tu dois te sauver. Et même des fois, maintenant c'est les hommes, ils prennent les femmes aussi pour pervers narcissiques. Quoi d'autre comme personnalité ? Dans la rue, qu'est-ce que vous dites des fois ? Estrionique et hystérique, oui.

Antisocial, bordel. Aïe, la personne sociale bordel. Bordel, comment on va détecter le bordel ? Ce qu'ils ont de stable, les personnalités bordel, c'est leur instabilité.

Ils sont stables dans leur instabilité. C'est une personnalité difficile à détecter. Mais c'est vrai, quand on ne comprend pas, on dit, il est bordel aïe.

Paranoïaque aussi, parano. Alors, la personnalité se manifeste par des tendances, des sentiments d'un homme, la façon dont il est impressionné par les situations dans lesquelles il se retrouve et dont il réagit. Donc c'est les tendances et les sentiments de chacun, comment il est impressionné par l'environnement et comment il réagit à cet environnement en fonction de ce qu'il ressent, ou bien en fonction de la façon avec laquelle il est impressionné.

Alors c'est la résultante et l'intégration des divers composantes pulsionnelles, émotionnelles et cognitives. Et on va voir dans les critères de chaque personnalité, c'est ces composantes qui vont être décrites. C'est la composante pulsionnelle dans chaque personnalité, émotionnelle et cognitive.

Pulsionnelle, c'est les réactions impulsives que vont réagir les gens. Émotionnelle, c'est la réaction par leur affectivité. Cognitive, c'est par leur pensée.

Ils réagissent à un événement en fonction de ce qu'ils pensent de cet événement. Alors la meilleure façon que j'ai vue de vous présenter le cours, c'est les critères DSM de chaque personnalité. Parce que si j'ai à votre été chaque personnalité à part, alors chaque personnalité fait 10 jours.

Mais si je veux la résumer, c'est en deux heures, chaque personnalité en deux heures. Là, on va

faire une heure pour toutes les personnalités. Alors les modalités de cette intégration, elles sont spécifiques et particulières à chaque individu.

Chaque individu a une façon d'intégrer ce qui est pulsionnel, de ce qui est émotionnel, de ce qui est cognitif chez lui. C'est pour ça que la personnalité dialecte, chez lui il y a la personnalité dialecte, chez lui il y a la personnalité dialecte. C'est pour ça que c'est différent.

Mais on peut retrouver des caractéristiques communes dans l'agencement des différents facteurs entrant en jeu. Qu'il y ait des caractéristiques communes, et c'est ça qui va caractériser par exemple des générations. Surtout les mamans.

Donc ça, c'est des choses qui peuvent être communes aux différents individus. Alors il y a une différence entre le caractère et le tempérament. Le caractère, c'est l'aspect extérieur de la personnalité.

Ce qu'on va voir au niveau de la personnalité, c'est comment il se manifeste. L'anti-social par exemple, il va être un bagarreur, un impulsif, un agressif. C'est un caractère irritable.

C'est ce qui va être apparent au niveau du comportement. Donc c'est des traits gravés qui sont observables, qui chez un individu ou un groupe définissent une manière habituelle de se comporter dans un certain type de situation. Et le caractère, bien sûr, me laisse prévoir comment cette personne va se comporter devant une situation.

Par exemple, on sait très bien, la maman sait très bien comment son mari se comporte quand son fils rentre tard. Quand le fils rentre tard, ivre par exemple, comment le père va se comporter. Il va être en colère.

Donc ce caractère du père, on le connaît en fonction de cette situation. Donc on peut prévoir le comportement. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des traits qui sont gravés et qui sont habituels à chaque situation.

Ils vont se répéter à chaque situation. Parce qu'on sait comment il va réagir. Le caractère est durable et stable.

La personnalité aussi. Donc est-ce qu'on change une personnalité ? Quelqu'un qui a un trouble de personnalité anti-social. Borderline.

Paranoïaque. Est-ce qu'on le change complètement ? On ne peut pas le changer. On l'assouplit tout simplement.

Mais on ne change pas complètement. Ça ne guérit pas. Il n'y a pas une guérison d'une personnalité.

Alors, quand on parle de personnalité pathologique, c'est une déviation permanente, purement

quantitative. Parce qu'on va le voir dans les différentes personnalités, on a tous des traits. Anna, j'ai un trait de personnalité histrionique.

J'ai des traits de personnalité anti-social. J'ai des traits. D'accord ? Mais sur le plan quantitatif, je ne réponds pas à la définition pour chaque personnalité.

Je n'ai pas la quantité de critères. Parce qu'on va voir, pour chaque trope de personnalité, il faut un certain nombre de critères. Donc, je ne réponds pas à tous les nombres.

Mais on a tous des traits dans chaque personnalité. J'ai des traits de personnalité obsessionnelle. Par exemple, je ne suis pas obsessionnelle.

Alors, le diagnostic de personnalité pathologique, il doit s'opposer en dehors de tout épisode psychiatrique symptomatique aigu. Quand vous êtes devant un déprimé, vous ne dites pas qu'il est déprimé avec une personnalité borderline sous-jacente. Vous faites le diagnostic de la dépression.

Une fois la dépression stabilisée, vous pouvez chercher s'il y a une personnalité borderline sous-jacente. Bien sûr, on cherche à l'anamnèse s'il y a des troubles de personnalité pathologique pré-morbide avant l'installation de la pathologie psychiatrique. Alors, dans tous les troubles de personnalité qu'on va voir, il y a des déviations.

Et cette déviation va se manifester au moins dans deux domaines. Soit la cognition, c'est la perception et la vision de soi-même, des autres et de l'événement, par exemple, de soi-même. L'auto-dévalorisation, c'est une vision négative de soi.

Ou bien l'hyperestimation de soi. Chez qui on va trouver cette hyperestimation de soi ? Dans les troubles de personnalité, il n'y a pas le bipolar. Les troubles de personnalité, ce n'est pas les pathologies psychiatriques.

Vous l'avez dit tout à l'heure, le narcissique. Donc, on va avoir une surestimation de soi. Alors, la sous-estimation, ça peut être chez la personnalité dépendante.

La vision des événements, c'est la méfiance. Chez qui, c'est le paranoïaque. Les personnalités schizotypiques, il y a la méfiance.

On s'approche de la schizophrénie. L'affectivité aussi, c'est un domaine qui va avoir des modifications. Soit par rapport à la diversité, soit l'intensité, soit la labilité, le changement des émotions.

L'affectivité, on a une labilité dans les émotions chez le Word Online. On a une diversité, une intensité des émotions chez qui ? L'hystérique. Le fonctionnement interpersonnel, pratiquement chez toutes les personnalités.

Chez le narcissique, bien sûr, il va y avoir un problème de fonctionnement interpersonnel, surtout avec le conjoint. Le contrôle des impulsions, on peut le trouver surtout chez l'antisocial. Ça, c'est les quatre domaines au niveau desquels on va avoir des modifications.

Il suffit de deux domaines modifiés pour qu'on se retrouve devant un trouble de personnalité. Les personnalités pathologiques, c'est des mentalités qui sont durables et rigides. Bien sûr, ça entraîne une souffrance.

C'est un monde qui est stable et prolongé, qui commence au plus tard à l'adolescence ou bien au début de l'âge adulte. Et bien sûr, elle n'est pas expliquée par une pathologie mentale ou par la prise de substances. Si, par exemple, un alcoolique est en état d'ivresse et commence à insulter à un cri, c'est par un psychopathe.

Alors, voilà les différents troubles de personnalité. Il n'y a pas les troubles psychiatriques. Il y a l'esthronique, l'antisocial, le borderline, le narcissique, le paranoïaque, le schizopside, le schizotypique, l'évitant, l'indépendant, l'obsessif, l'impulsif.

On va voir les critères et vous allez voir que vous pouvez quand même faire la séparation entre les différentes personnalités. La personnalité esthronique, on a souvent entendu qu'elle fait le théâtre. Elle ne fait pas le théâtre.

Elle est le théâtre. Elle est elle-même le théâtre. Elle est théâtre.

Elle n'est pas un acteur. Elle est acteur. Elle n'a pas d'émotions.

Elle est des émotions. C'est une boule d'émotions. Alors, c'est un mode.

Ce qui est caractéristique chez cette personnalité, c'est les réponses émotionnelles excessives. C'est pour attirer l'attention. Vous vous rappelez l'esthronique, c'est le théâtral.

C'est pour attirer l'attention. Retenez ça et vous allez voir que tous les critères sont autour de ça. Le sujet est mal à l'aise quand il est dans une situation où il n'est pas au centre de l'attention d'autrui.

L'interaction avec les autres est souvent caractérisée par un comportement de séduction sexuelle inadapté et une attitude provocatrice pour attirer l'autre, toujours dans le même sens. Attirer l'attention. Expression émotionnelle superficielle et rapidement changeante.

Elle peut se mettre rapidement en colère et rapidement elle commence à rigoler. L'hystérique. Utilise régulièrement son aspect physique pour attirer l'attention.

Manière de parler trop subjectif mais pauvre en détails. Donc, parle juste de façon superficielle, juste pour attirer l'attention. Pour ne pas dire quelque chose d'important.

Dramatisation, théâtralisme, exagération. Et dramatise une chose, rien du tout, juste pour attirer l'attention. Suggestibilité est facilement influencée par autrui ou par les circonstances.

Elle est là en crise, elle va perdre connaissance et tout le monde va la solliciter, tout le monde va essayer de la réveiller. Mais quand il va y avoir un voisin ou bien un cousin qui va arriver, quelqu'un qui vient de l'étranger par exemple, qu'elle cherche par exemple à séduire, à attirer l'attention, elle va essayer de la réveiller. Elle va se réveiller rapidement.

Donc c'est la suggestibilité. Rapidement, elle change en fonction des circonstances. Considère que ses relations sont plus intimes qu'elles ne le sont en réalité.

Donc il va parler d'une amie intime, je la connais très bien, oui on a fait ça ensemble, alors que ce n'est pas vrai. Juste pour montrer qu'elle est importante ou bien pour attirer l'attention des autres. Donc vous voyez, ça vous donne une idée et ça permet de faire la différence avec les autres.

Chez l'homme histrionique, c'est un petit peu difficile. On peut accepter une femme avec une personnalité histrionique, mais un homme très souillant, vous avez déjà rencontré des hommes, ce n'est pas connu aux hommes. Vu leur virilité, c'est quelque chose qui va être un petit peu détecté.

On va le détecter rapidement. Des soucis de paraître, une recherche de séduction, une quête de virilité, donc ils vont aussi dans le même sens. Mais c'est rare qu'on voit un homme qui cherche à séduire, ce n'est pas comme les femmes.

Souci de ce qu'on va dire de lui, comment il est habillé, sa façon de parler. Il va faire attention à ce que les autres disent de lui, des conduites psychopathiques des fois pour attirer l'attention, pour montrer sa virilité. Donc il va chercher par exemple avec une femme à la défendre devant les autres, entrer en bagarre avec les autres hommes par exemple, les autres garçons.

Hésitation et incapacité à s'engager, ça reste un défi quand même. Il y a des conduites d'alcoolisation chez les hommes histrioniques. Ça se rapproche de la personnalité passif-dépendant.

On voit chez cet homme un féminisme de l'immatunité, mauvais contrôle émotionnel, s'énervier rapidement aussi, mettre en colère rapidement, ne pas parler avec son conjoint ou son ami, hypersensible, inhibition sociale, il peut se retirer des contacts sociaux. L'antisocial, là c'est évident. Vous voyez comme je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la quantité, ici 5, 7 par 8, 8. Comme je vous ai dit, je peux avoir un trait, ma façon de parler peut-être hystérique quand je fais comme ça par exemple, mais je n'ai pas les 5 parmi les 8. Ici 3 parmi les 7. Donc incapacité, ça vous fait rire, j'ai mes traits histrioniques, j'ai même des traits antisocial.

Vous aussi vous en avez ? Alors l'antisocial c'est le psychopathe que vous connaissez, et vous

allez voir dans les critères, c'est quelque chose aussi d'évident, c'est une incapacité à se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, comme indiquer la répétition de comportements passibles d'arrestation. Des entrées et sorties en prison, bien au commissariat. Ils font des passages réguliers en prison, incarcérés plusieurs fois, arrêtés plusieurs fois, parce qu'ils ne respectent pas la loi.

Tendance à tromper par profit ou par plaisir. Là, des choses qui ne vont pas vous paraître antisociales, psychopathiques, mais les mensonges répétés, c'est antisocial, c'est tromper les autres. L'utilisation de pseudonymes, c'est tromper les autres, ne pas respecter la loi.

Les escroqueries, c'est ne pas respecter la loi, c'est antisocial. L'impulsivité, l'incapacité à planifier à l'avance les choses. L'irritabilité, l'agressivité indiquée dans la répétition des bagarres.

Ils ont une adolescence orageuse, des bagarres dans leur antécédent, des agressions, des arrestations multiples. Mépris, inconsidéré pour sa sécurité ou celle d'autrui. Quand ils sont dans les bagarres, quand ils prennent des risques, ils ne font pas attention.

Il peut se faire mal, il peut même se tuer, il s'en fiche. Il s'en fiche même pour les autres, le mépris des autres. Donc, irresponsable, incapacité d'assumer un emploi stable, bien sûr.

Absence, et ça c'est aussi une caractéristique, c'est l'absence de remords. Il ne va pas se culpabiliser, il ne va pas critiquer ce qu'il fait, même s'il fait mal aux autres, absence de remords. Donc ici, on précise l'âge, c'est toujours à partir de fin de l'adolescence, début de l'âge adulte.

Alors, le bord online, là on voit le bord online. Il faut cinq des caractéristiques suivantes. C'est un mode général d'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects avec une impulsivité marquée.

Donc, il apparaît, comme j'ai dit, début de l'âge adulte et présent dans des contextes divers. Donc, c'est la stabilité par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Alors, c'est des efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginaires.

Des abandons réels, elle est en conflit avec son mari, son mari la menace de l'abandonner. Donc ça, c'est un fait réel. Il va faire tous les efforts pour empêcher son mari de l'abandonner.

Ou bien, elle est là dans une relation stable, mais elle est toujours dans cette peur qu'un jour, son mari va l'abandonner, sa copine va l'abandonner, sa maman va l'abandonner. Donc, un abandon qui est imaginaire. Donc, elle fait tous les efforts pour les empêcher de l'abandonner.

Et bien sûr, ça, ça crée des problèmes. Rien que le mari, quand il va sortir, par exemple, est-ce que tu vas revenir ? À quelle heure tu vas revenir ? Tu es sûr que tu vas revenir ? Non, je viens avec toi. Ça, des fois, c'est agaçant.

Mode de relation interpersonnelle instable et intense, caractérisé par l'alternance entre des

positions extrêmes, d'idéalisation excessive et de dévalorisation de l'autre. Donc, il va idéaliser de façon excessive son conjoint, son ami, sa maman, et des fois, il va les dévaloriser. Vous êtes nul, vous ne valez rien, vous n'avez jamais été là pour moi, vous ne m'avez jamais aidé, vous n'avez jamais rien fait pour moi.

Donc, c'est dans les extrêmes. C'est une instabilité dans la relation. Instabilité marquée et persistance par rapport à l'image et la notion de soi.

Des fois, il s'aime, il va aussi dans l'idéalisation excessive de soi. Des fois, il se déteste, il se dévalorise et il fait beaucoup de tentatives de suicide, beaucoup d'automutilation. L'impulsivité dans au moins deux domaines avec des conséquences négatives, des dépenses exagérées, des comportements sexuels à risque, de la toxicomanie, des crises de boulimie, beaucoup de crises de boulimie et de conduite automobile dangereuse.

Comme je vous ai dit, beaucoup de délits suicidaires, de tentatives de suicide, d'automutilation. Ça aussi, c'est une caractéristique du borderline. Et les femmes aussi.

Vous voyez, même les femmes qui ne sont pas obligatoirement des consommateurs de drogue. On peut trouver une femme, une jeune fille qui n'a jamais consommé avec des automutilations, comme chez les psychopathes. Instabilité affective due à une réaction marquée de l'humeur.

Dysphorie épisodique intense et des sauts de haut et bas de l'humeur. Irritabilité, anxiété qui va durer quelques heures et rarement quelques jours. Ils ont aussi cette caractéristique de l'habileté de l'humeur.

Instabilité affective, instabilité de l'humeur. Aussi une caractéristique très importante, c'est le sentiment de vide. L'ennui et le sentiment de vide dans leur vie.

Et ça, ils vont l'exprimer. Je m'ennuie, je ne fais rien, je n'ai rien à faire. Même s'ils font des choses, vous essayez de les encourager.

Oui, mais ça, c'est rien. Donc, des colères intenses et inappropriées. C'est en rapport avec les sauts d'humeur.

Survenue transitoire dans une situation de stress, d'une idéation persécutive ou de symptômes dissociatifs sévères par rapport aux autres. Donc, persécution par rapport au conjoint. Ils ne m'aiment pas à la maman, ils ne m'aiment pas à une amie.

Ils cherchent à me faire du mal, ils ne m'aiment pas. Et ça aussi, ça peut les faire entrer dans des états dépressifs. Ils font aussi beaucoup de dépression avec des idées suicidaires.

Donc, six caractéristiques chez cette personnalité, c'est leur instabilité relationnelle. Leur instabilité dans l'évaluation de l'autre et de soi-même. C'est l'impulsivité, les idées suicidaires et les variations de l'humeur.

Le sentiment de vide et les crises de colère. Le narcissique, on vient au narcissique. Alors, le narcissique, c'est quelqu'un qui a un mode de vie dont des fantaisies, de comportements grandioses, besoin d'être admiré et de manque d'empathie.

Il a besoin d'être admiré par les autres et il n'a pas d'empathie pour les autres. Entre guillemets, il se prend pour Dieu. Vous allez voir, il faut cinq des neuf critères.

Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance. Surestime ses réalisations, ses capacités. Même s'il fait quelque chose de minime, il va surestimer, surévaluer ce qu'il a fait.

Il est le meilleur. Personne ne peut accomplir ce qu'il a fait. A-t-on à être reconnu comme supérieur sans avoir accompli quoi que ce soit ? Même s'il ne fait rien, on doit le considérer comme le supérieur, comme le patron, le père de la famille.

Celui qui, sans lui, le monde ne vaut rien. Il est absorbé par des fantaisies de succès illimités, de pouvoir, de splendeur, de beauté et d'amour idéal. Donc pour lui, c'est lui le chef, c'est le meilleur, c'est lui qui va pouvoir guider la famille, guider les autres, et il doit avoir l'amour des autres.

Vous allez détester cette personnalité. Pense être spécial et unique. Et ne pouvoir être admis, c'est la meilleure, ne pouvoir être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux et de haut niveau.

Besoin excessif d'être admiré. Si quelqu'un l'est toute la journée, il faut l'admirer, il faut le lui dire toute la journée. Et bien sûr, il ne va l'accepter que par des gens qui sont spéciaux et de haut niveau.

Pense que tout lui est dû. Ça encore c'est grave. Satan, sans raison, a bénéficié d'un traitement particulièrement favorable et à ce que ses désirs soient automatiquement satisfaits.

C'est lui qu'on doit servir comme un roi. J'ai oublié comment on l'appelle. Encore pire, il va exploiter l'autre dans les relations interpersonnelles, utilise l'autre pour parvenir à ses propres fins.

Il va utiliser les autres pour parvenir à ses propres fins. Avec tout ça, il manque d'empathie. Il n'est pas disposé à reconnaître ou à partager les sentiments et les besoins d'autrui.

Il s'en fiche des autres. Encore, il en vit souvent les autres et croit que les autres l'ont envie. Il en vit les autres et croit que les autres l'ont envie.

Parce que lui, il est le plus important. C'est normal que les autres l'aiment. Donc, fait preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain.

Ici, c'est la mégalomanie. Comptez-les avec vous. C'est l'attitude arrogante et hautaine.

Je crois que c'est tout. C'est une personnalité à part. Vous l'avez vraiment détectée.

On voit cette arrogance, cette surestimation de soi, la méprise des autres, et chercher à être aimé comme s'il a accompli des miracles. Bien sûr, il utilise les autres pour subvenir à ses besoins. La personnalité paranoïaque, là, c'est le parano.

Quand on dit parano, c'est la méfiance. Les adolescents lui disent entre peu, tu es devenu parano, c'est de la paranoïa que tu as. Ça veut dire que l'adolescent devient méfiant, soupçonnant par rapport aux autres.

Donc, le sujet s'attend. Vous avez fait la paranoïa. Vous allez voir les traits de cette personnalité.

Le sujet s'attend sans raison suffisante à ce que les autres l'exploitent, lui nuisent ou le trempent. Très méfiant des autres. Si on est méfiant, on a peur des autres qui nous exploitent.

Et préoccupé par des doutes injustifiés concernant la loyauté ou la fidélité de ses amis ou associés. Ça va de soi. Quand on a peur que les autres nous exploitent, bien sûr, on va avoir des doutes par rapport à la loyauté des autres.

Donc, il va être toujours méfiant. Et réticent à se confier à autrui dans le même sens. Puisqu'on est méfiant, il ne va pas pouvoir se confier aux autres par crainte injustifiée de ce qu'il va dire aux autres.

L'information qu'il va donner aux autres va être utilisée contre lui. Discerne des significations cachées, de façon interprétative. Il va discerner et interpréter des significations humiliantes ou menaçantes dans des commentaires ou des événements anodins.

Il va dire « As-salamu alaykum » et je lui dirai « As-salamu alaykum ». Vraiment, c'est quelque chose de rien du tout. Il se méfie beaucoup, il fait beaucoup attention. Et quoi que vous faites, il y a toujours quelque chose derrière qui va leur faire du mal.

Bien, vous dites ça parce que vous voulez quelque chose. Garde rancune, ne pardonne pas d'être blessé, insulté ou dédaigné. Perçoit des attaques contre sa personne ou sa réputation alors que ce n'est pas apparent pour les autres et réagit.

Ça, c'est interprétation avec colère, donc il interprète de façon négative tout ce que vous faites, tous les comportements des autres, comme c'est des attaques contre lui alors que ce n'est pas apparent pour les autres. Les autres vont dire « Mais il n'a rien signifié, il n'a rien dit. Mais si, si, moi je sais.

Je sais ce qu'il y a derrière. Il a fait ça pour me faire du mal. Il a dit ça pour m'humilier devant les autres.

» Mais en doute de manière répétée et sans justification à la fidélité de son conjoint. Là, vous

l'avez vu, dans la pathologie paranoïaque, il y a un délire d'infidélité du conjoint. Donc ça, c'est par rapport au paranoïaque.

Aussi, on voit qu'il y a des caractéristiques qui sont spécifiques. C'est surtout la méfiance et c'est tout autour de la méfiance. « Je me méfie des autres.

Ils vont me faire du mal. Je ne vais pas me confier aux autres. » Schizouïde, alors il y a schizouïde et il y a schizotypique.

Schizotypique, on est proche de la schizophrénie. Quand je vous dis schizotypique, rappelez-vous les symptômes de la schizophrénie. Schizouïde, si vous étudiez en médecine, quand vous avez commencé la médecine, alors c'est un mode de détachement par rapport aux relations sociales.

Quand vous avez commencé la médecine, vous avez continué à aller au... Vous avez continué à participer aux fêtes. Vous êtes enfermés, isolés, dans la famille. Je me rappelle qu'il n'y avait plus d'égo dans la famille.

On n'avait plus d'égo pour les autres. Mes soeurs et frères, quand je quittais le lien, tellement ils ne me voyaient plus. Donc ça, ici vous voyez un petit peu un sujet qui est isolé, un petit peu difficile, qui ne pose pas de problème.

Donc on doit avoir quatre des sept symptômes. Le sujet ne cherche ni n'apprécie les relations proches, y compris les relations intrafamiliales. À l'adolescence, il rentre, il s'enferme dans sa chambre.

Ou bien même quand il rentre, il est avec les autres, il ne peut pas parler avec les autres, ne pas communiquer avec les autres. Mais il est tranquille. Il choisit presque toujours des activités solitaires.

Même par exemple, pour faire le sport, tu veux faire du foot ? Non, je fais le tennis. Ou bien une activité où il va être tout seul. Il n'a que ou pas d'intérêt pour les relations sexuelles, parce qu'il n'a pas vraiment des amis intimes.

Il n'y prouve de plaisir que dans de rares activités, sinon dans aucune. Rien ne lui fait plaisir. Il est un petit peu déficitaire, anhédonique, s'enferme chez lui, faire les choses de façon très simple.

Il n'a pas d'amis proches ou de confidants en dehors de ses parents. Donc s'il a vraiment des choses à partager, c'est avec les parents, même pas avec les frères et sœurs et même pas avec les amis. Il semble indifférent aux éloges, aux critiques.

Quand vous lui faites des éloges, rien du tout. Il fait preuve de froideur, de détachement ou d'émoussement affectif. Quand la famille, par exemple, il y a un deuil, il est là, il peut vraiment

marcher avec la participation affective avec les autres.

Donc ici, c'est schizouïde. Et ça, on le voit beaucoup des enfants comme ça, des adolescents comme ça. Bien sûr, il faut éliminer une évolution schizophrénique.

Il faut éliminer un trouble de l'humeur ou bien un problème toxique. Schizotypique, là, vous voyez qu'on va s'approcher de la schizophrénie. On va rapporter vraiment des idées en rapport avec les hallucinations, avec des délires.

Ici, c'est un mode général de déficit sensoriel et interpersonnel marqué par une gêne aiguë et des comportements réduits, dont les relations avec les proches, des distorsions. Là, ça commence les interprétations erronées, des distorsions cognitives, perceptuelles, des interprétations dans la perception des événements, des conduites un petit peu excentriques, pour ne pas dire bizarres, qui commencent. Alors, il y a des idées de référence.

Ce ne sont pas des idées délirantes de référence. C'est quoi les idées délirantes de référence ? Chez le schizophrène, c'est quoi les idées de référence ? Délirante, c'est un délire. Le syndrome de référence, vous l'avez fait.

En semiologie ou en pathologie schizophrénique. C'est quand il vous dit, par exemple, on parle de moi à la télé, on parle de moi dans les journaux, à la radio. On parle de moi.

Ici, ce ne sont pas des idées vraiment délirantes, mais il va vous dire qui m'est et où est l'IA. Il va vous dire ça m'arrive aussi, ça m'arrive. Ou bien c'est comme si on me désigne.

C'est des idées de référence sans que ça soit vraiment délirant. Des croyances bizarres ou des pensées magiques qui influencent le comportement et qui ne sont pas en rapport avec les normes d'un groupe culturel. Par exemple, les superstitions.

J'ai un don. A chaque fois que je pense à ça, ça arrive. A chaque fois que j'y pense, ça arrive.

Je peux deviner ce qui va arriver, mais sans que ce soit des croyances bizarres. Croyances bizarres, ça peut aller, par exemple, jusqu'à je peux faire tomber la pluie, par exemple. Je peux changer le temps, par exemple.

Mais là, c'est soit de la superstition, soit de la télépathie, soit des voyants, soit le fait comme s'il a un sixième sens. Ça, c'est des croyances bizarres. Des perceptions inhabituelles se forment souvent d'illusions corporelles.

Donc, ce n'est pas des hallucinations. Vous faites la différence entre hallucinations et illusions. La vision, la perception, elle est déformée d'un objet réel.

Alors que dans l'hallucination, c'est la perception sans objet. L'objet n'est pas là. Quand vous êtes chez vous, par exemple, vous voyez dans votre chambre un manteau accroché, vous pouvez le

prendre pour quelqu'un, surtout la nuit, à l'endormissement.

Mais si le manteau n'est pas là, vous le prenez pour quelqu'un. Ça, c'est des hallucinations. Pensée est un langage bizarre, un langage métaphorique, un langage stéréotypé, un langage vare.

Des fois, on a du mal à le comprendre. Le schizophrène, son langage bizarre, il est clair. C'est des associations bizarres, c'est des mots nouveaux, jamais utilisés, qu'il utilise lui et ça a un sens.

Mais le schizotypique, c'est son langage qu'on n'arrive pas à comprendre. Soit il va parler par des métaphores, soit il va répéter des phrases, soit le langage est un petit peu flou. On a du mal à comprendre.

La méfiance et la persécution. Sans que ce soit, on n'est pas encore arrivé au délire. Il va être méfiant.

On cherche à me faire du mal. J'ai l'impression que quelqu'un me poursuit. Mais il n'est pas délirant, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir cette conviction inébranlable.

Inadéquation, pauvreté, désaffect. Un petit peu un émoussement d'affect. Comportement ou aspect bizarre, excentrique, par rapport à sa façon de s'habiller par exemple, il va être un petit peu bizarre.

Par rapport au choix, par exemple, de la nourriture, c'est quelqu'un qui va être bizarre. Par exemple, il va vous dire, moi je ne mange que les aliments en verre. Les aliments verts, de couleur verte.

Je ne mange que les aliments. Je ne mange pas les aliments qui sont ronds, par exemple. Il va faire des sélections par rapport aux aliments.

Et ça, c'est des éléments bizarres qui peuvent apparaître dès le début. Chez un schizophrène, quand on pose la question à la famille, on voit des symptômes en rapport avec ce qu'on trouve dans la personnalité schizotypique. Seulement, ces personnalités schizotypiques et schizovides, elles ne vont pas évoluer vers la schizophrénie.

Ce sont des gens qui vont fonctionner avec ce mode-là. C'est un mode de fonctionnement. Absence d'amis proches et de conflits en dehors des premiers parents.

On sait très bien que chez les schizophrènes, il n'y a pas d'amis. Anxiété excessive en situation sociale qui ne diminue pas quand le sujet se familiarise avec la situation. Ça, c'est la phobie sociale.

Et vous connaissez la limite entre phobie sociale et porte-entrée à la schizophrénie. Il y a des

phobies sociales qui sont atypiques et qui sont des portes d'entrée à la schizophrénie. Ici aussi, c'est une anxiété sociale.

Et même si le sujet se familiarise avec la situation, il garde cette phobie qui est surtout due à la persécution plutôt que le fait de mettre la barre plus haute et le jugement des autres. Donc, vous voyez, dans le schizoid, c'est un mode de fonctionnement à minima, solitude, pas envie d'amis, quelqu'un qui ne participe pas beaucoup. Le schizoid, c'est le début des illusions, le début de la persécution, le début de la méfiance.

Aussi, il ne partage pas. Et sur le plan affectif aussi, il y a une pauvreté des affects. La personnalité évitante, après dépendante, après rétro-personnalité.

La personnalité évitante, c'est un sentiment de ne pas être à la hauteur et d'hypersensibilité au jugement négatif de l'autre. Là, dans la sensibilité évitante, ça va vous rappeler quel type de pathologie ? Oui, la phobie sociale. Donc, le sujet évite les activités sociales professionnelles qui impliquent les contacts importants avec autrui par crainte d'être critiqué, désapprouvé ou rejeté.

Réticence à s'impliquer avec autrui, à moins d'être certain d'être aimé. Toujours la peur d'être jugé, d'être sensible aux critiques de l'autre. Réserve dans les relations intimes par crainte d'être exposé à la honte et au ridicule.

De ne pas être performant, par exemple sexuellement, il va être exposé à la honte de la part du conjoint. Crainte d'être critiqué ou rejeté dans les situations sociales et inhibé dans les situations interpersonnelles nouvelles à cause d'un sentiment de ne pas être à la hauteur. Se perçoit comme socialement incompetent, sans attrait ou inférieur aux autres.

Et particulièrement réticent à prendre des risques personnels ou à s'engager dans une nouvelle activité par crainte d'éprouver de l'embarras. Tout autour du jugement de l'autre. Donc ça, rien au niveau des définitions, c'est le mode général de fonctionnement qui vous donne une idée sur les critères.

Donc l'évitante, c'est un rapport, si vous voulez, ça vous rappelle la pathologie phobique sociale. La personne était dépendante, c'est une personne qui était aussi difficile à vivre. Donc ici, il conduit à un comportement soumis et collant, et à une peur de la séparation.

C'est avoir peur d'être abandonné. Le sujet a du mal à prendre des décisions dans la vie courante sans être rassuré ou conseillé de manière excessive par autrui. Imaginez, comme vous lisez la personnalité, de voir la personne.

Imaginez quelqu'un comme ça, qui a toujours, tout le temps, besoin de l'autre. Dans toutes les décisions. Il va poser la question.

Il a besoin que l'autre assume les responsabilités dans la plupart des domaines importants de sa vie. Il ne prend pas de responsabilités. À la rigueur, une femme, ça peut être acceptable.

Imaginez un homme comme ça. Donc, il a peur de prendre les responsabilités. Il a du mal à exprimer un désaccord avec l'autre.

Un désaccord, ça c'est pire, un désaccord avec autrui, de peur de perdre son soutien ou son approbation. Il va être tout le temps d'accord avec les autres, par peur de perdre le soutien des autres. Il est soumis aux autres.

Il a du mal à initier des projets ou à faire des choses seul, par manque de confiance en son propre jugement ou en ses propres capacités, plutôt que par manque de motivation ou d'énergie. Cherche à obtenir le soutien et l'appui d'autrui, au point de faire volontairement des choses désagréables. Ici, il est à la recherche du soutien d'autrui.

Il demande, il supplie, il supplie. Il est soumis par rapport à la personnalité évitante. Non, il ne demande pas.

Il a peur des jugements, mais il n'est pas dans la soumission, dans la dépendance. Cherche à obtenir le soutien et l'appui d'autrui, au point de faire volontairement des choses désagréables. À quel point il est soumis ? Se sent mal à l'aise ou impuissant quand il est seul, par crainte exagérée, d'être incapable de se débrouiller.

Ça peut vous rappeler une femme dépendante, mais c'est rare qu'on voit vraiment un homme dépendant comme ça. Lorsqu'une relation proche se termine et cherche de manière urgente une autre relation qui puisse assurer le soutien dont il a besoin. Il est préoccupé de manière irréaliste par la crainte d'être laissé à se débrouiller seul.

Ce n'est pas comme la peur de Borderline, et le besoin de l'autre, et la peur de l'abandon, pour un besoin affectif. Ici, c'est pour un besoin de tous les jours, des décisions de tous les jours. Il ne peut pas avancer, il ne peut rien faire sans l'aide de quelqu'un d'autre.

Il est tout le temps à demander, est-ce que je choisis ça ou ça ? Est-ce que je fais ça ou ça ? Même pour les choses les plus simples de la vie. Ici, c'est la soumission, c'est la dépendance, c'est vraiment la soumission jusqu'au point de faire des choses désagréables. Il ne fait rien tout seul.

La personnalité obsessionnelle-compulsive, ça va vous rappeler aussi certains symptômes de troubles obsessionnels-compulsifs. Ici, on voit aussi le mode général de fonctionnement. Ce sont des gens qui aiment l'ordre, qui aiment le perfectionnement, le contrôle mental et interpersonnel.

C'est surtout ce perfectionnement et l'ordre. Préoccupation pour les détails, les règles, les inventaires, l'organisation, les plans, au point, bien sûr, qu'ils passent beaucoup de temps dans les détails pour arriver à un objectif, au point de ne pas... Le but principal, il est perdu. Ils sont là à perdre du temps sur les détails avant d'arriver à la fin de la tâche.

Perfectionnisme qui entrave l'achèvement de la tâche. Des fois, ils ne terminent pas les tâches par le temps, à cause du temps qu'ils perdent dans l'accomplissement de cette tâche qui doit être perfectionnée. Dans la perfection, dans les détails.

Ils sont très stricts. Dévotion excessive pour le travail et la production à l'exclusion des loisirs et des amitiés. Donc, ils vont être perfectionnistes dans leur travail, trop consensueux, scrupuleux et rigides sur des questions de morale, d'éthique ou des valeurs.

Donc, ils n'ont pas le temps pour les loisirs. Ils sont très stricts et très consensueux. Incapables de jeter les objets usés.

Ça, c'est comme vous. Ils sont utilisés même si ceux-ci ne sont pas de valeur sentimentale. J'imagine que vous avez un trait comme ça.

Moi, j'ai ce trait-là. Incapables de se séparer des choses, même dans votre armoire. Vous allez trouver des fois des vêtements que vous n'utilisez pas, mais vous le gardez peut-être que vous allez le mettre un jour.

D'accord? Il y a une technique pour se débarrasser des vêtements que vous ne mettez pas. Soit vous les mettez à l'envers et s'ils restent comme ça pendant longtemps dans l'armoire, là, vous les enlevez. Ça veut dire que vous ne les utilisez pas.

Alors, réticence à déléguer des tâches ou à travailler avec autrui, à moins, bien sûr, puisqu'ils sont perfectionnistes, ils ne vont pas faire confiance aux autres. Donc, ils vont vouloir tout faire. Ils ne vont pas déléguer des tâches parce que pour eux, vous, vous n'êtes pas aussi perfectionniste qu'eux.

Vous n'allez pas faire la tâche comme ils veulent. Se montrer avare avec l'argent pour soi-même et pour les autres. L'argent est perçu comme quelque chose qui doit rester en vue de catastrophes futures.

Se montrer rigide et têtu. Ils veulent tout faire de façon rigoureuse, scrupuleuse, dans un ordre bien précis. Donc, ils sont rigides et têtus dans ce sens et ils ne délèguent rien aux autres.

Ils fonctionnent comme ça. C'est des gens qui fonctionnent comme ça et qui vivent leur vie comme ça. Alors, tous les troubles de personnalité qu'on a vus, il y en a qui se rapprochent de certaines pathologies que vous avez vues.

Dans les pathologies que vous avez vues, que ce soit la phobie sociale, l'esquizophrénie, ce n'est pas obligatoire d'avoir une personnalité pathologique sous-jacente. Mais les troubles de personnalité, ce sont des gens qui peuvent vivre comme ça pendant des années et en général, ça peut entraîner beaucoup plus de souffrance pour l'entourage que pour eux. On ne les traite pas, on ne les élimine pas, mais on les assouplit.

D'accord ? Et on a fini. Il y a un cours que je n'ai pas fait, je ne vais pas le faire, c'est le cours sur l'histoire de la psychiatrie. Je vous laisse le lire.

Et si je vous dis que je ne vais pas poser de questions, je suis sûre que vous n'allez pas le lire. Mais vous pouvez au moins le lire pour avoir une idée sur l'histoire de la psychiatrie. Très bien.

Dans les pathologies psychiatriques, vous avez vu des conséquences, vous avez vu de la souffrance sur le sujet lui-même. Ce n'est pas un mode de vie. Le sujet, par exemple, dans l'obsessif compulsif, il vit sa vie.

Il a sa vie, il va à l'école, il vient, mais par des moments, il a ses tocs, il a ses symptômes. Dans la personnalité obsessionnelle-compulsive, toute sa vie, c'est comme ça. Toute la démarche de sa vie, c'est comme ça.

Par exemple, le toc de lavage, c'est au moment où il va se laver les mains, où il va y avoir ce toc de lavage. Mais pas toute sa vie. Après, il va à l'école, il va travailler, alors que la personnalité obsessionnelle-compulsive, on n'a pas comme symptômes le lavage des mains, on n'a pas tous les symptômes qu'on a vus, les quatre catégories que vous avez vues, les laveurs, les vérificateurs.

C'est uniquement au niveau de la vérification ou au niveau du perfectionnisme. Ça ne regroupe pas tous les symptômes. Dans le toc pathologie, on a plusieurs symptômes.

Il y a des conséquences autres. Ça, c'est les conséquences par rapport, c'est surtout dans le sens relationnel. Alors que dans le toc pathologie, ça peut se compliquer d'une dépression, ça peut amener au suicide.

Ici, c'est son mode de vie, c'est son mode de fonctionnement. Ça peut lui entraîner une souffrance, ça peut entraîner de la souffrance à la famille, mais pas au point de la pathologie. Et dans le trouble obsessionnel-compulsif, la pathologie, c'est pas obligatoire d'avoir une personnalité obsessionnelle-compulsive.

D'accord ? Donc la différence, c'est au niveau des critères et au niveau du mode de vie. Oui ? Même si on n'a pas ? En général, il ne va pas venir s'il n'y a pas de souffrance. Mais c'est vrai, des fois, il faut les détecter.

Pourquoi ? Par exemple, vous êtes devant une patiente dépressive que vous traitez, vous donnez l'antidépresseur, vous suivez les guidelines, et ça ne s'améliore pas. Il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un trouble de personnalité sous-jacent ? Parce que s'il y a un trouble de personnalité sous-jacent, le trouble ne s'améliore pas. Sa dépression ne s'améliore pas.

Donc c'est vrai, il faut chercher s'il y a, soit si le patient vient lui-même par la souffrance, et s'il ne vient pas, des fois, vous devez chercher pour assouplir. Assouplir par la psychothérapie, il n'y a pas de traitement. Il peut développer, si vous voulez, il n'y a pas de statistiques, je ne veux pas

vous dire quelque chose qui n'y est pas, mais ce n'est pas forcément obligatoire qu'il développe une pathologie schizophrénique.

Ce n'est pas obligatoire. On peut dire qu'il a le même risque, ou bien plus, parce qu'il a vraiment des critères qui s'approchent de la pathologie schizophrénique. Mais il peut fonctionner comme ça toute sa vie, sans avoir les conséquences.

Parce que la schizophrénie, il y a des complications, il y a des rechutes, ça ne tient pas à domicile. Il faut des hospitalisations, il faut un traitement. Le schizotype pique, on ne peut pas lui donner de traitement, et il peut fonctionner comme ça toute sa vie.

D'accord ? Oui, d'autres questions ? Oui. C'est la même question qu'a posée votre amie. Est-ce que le risque est le même que la population générale ? On n'a pas de doute.

Vu les symptômes, vu le mode de fonctionnement, ils ont plus de risque d'évoluer vers une pathologie. D'accord ? Parce que c'est un mode de fonctionnement cognitif, interprétation, relation interpersonnelle, donc ils ont plus de risque de développer une pathologie. Ça vous intéresse beaucoup les troubles de personnalité.

J'imagine que vous détectez ça autour de vous. C'est un jeu, oui. Non, le psychopathe, c'est l'antisocial.

On l'appelle psychopathe ou antisocial ? Psychopathe, ce n'est pas psychotique. Non. Psychopathe.

Comment on peut être un psychopathe ? Psychopathe, c'est l'antisocial. Maintenant, on ne dit plus psychopathe, on dit antisocial. C'est un psychopathe comme les autres.

On ne dit plus toxicomane, on dit addict. D'accord ? On ne dit plus alcoolique, on dit addict à l'alcool. D'accord ? Donc, psychopathe, c'est psychotique.

Psychopathe, c'est antisocial. Le terme, on ne l'utilise plus, on l'utilise antisocial. Oui.

À la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, c'est décrit dans tous les critères. Ils insistent sur ça. 15 ans, 18 ans, à février 18 ans, 15 ans.

Et c'est cité. Ils ont cité 15 ans. Oui.

Et vous allez faire psychiatrie. Vous allez faire psychiatrie. Les troubles de personnalité, c'est les derniers qu'on va évaluer une fois que la symptomatologie s'efface, se stabilise.

On va pouvoir l'évaluer et c'est difficile à évaluer. C'est par des échelles qui prennent beaucoup de temps. D'accord ? C'est bon ? Alors, je vous souhaite bon courage pour l'examen.

Je compte sur vous comme d'habitude. On a toujours des taux de présence.

